

Resumo de Mudanças — Revisão da Reunião de 13/07/2026

Projeto: Modelos institucionais de gestão e desempenho na rede hospitalar SUS-SP (2015–2025)
Responsável técnico: João Eduardo Pastori Garcia | Período coberto: 13–15/07/2026 (ciclo completo da revisão)
Documento-síntese para circulação à equipe (Priscilla Perdicaris, Alberto Tomasi)

1. O que este ciclo fez

A partir dos 12 encaminhamentos da reunião de 13/07, o ciclo executou: (i) investigação somente-leitura de todos os itens, com relatório e gate de aprovação; (ii) aplicação das correções liberadas, uma a uma, com diff e verificação; (iii) fechamento da lista de exclusão de hospitais de perfil incomparável (21 CNES, pendente de ratificação); (iv) memorando com as três decisões que dependem da equipe. **O painel em disco continua o de 314 hospitais (pré-mudanças estruturais):** as exclusões e a regeneração completa acontecem em ciclo único (Etapa 3), depois das ratificações.

2. Correções aplicadas (código e documentação)

Item	O que mudou
1.11 — Hospital Guilherme Álvaro (Santos)	Erro de rótulo de origem confirmado (consta "OSS" no SIH em todos os 11 anos, mas é administração Direta; não é conversor). Correção aplicada em <code>construir_painel_definitivo.py</code> via sobrescrita auditada de <code>modelo_gestao_proxy</code> ; a coluna-fonte fica intacta. Efeito: OSS 39→38 CNES, Direta 32→33.
1.2 — Nomenclatura "custo" → "faturamento"	Confirmado que a variável sempre foi reembolso SIH ÷ saídas (nunca custo contábil). Todos os rótulos humanos passaram a "faturamento por saída (SIH)" e "faturamento real por saída (R\$ de 2025)" — código, relatórios e texto LaTeX. Acoplada em todo ponto que cita o resultado OSS: a ressalva do regime de pagamento (OSS recebe por contrato de gestão/orçamento global, não por AIH — a diferença de faturamento pode refletir o próprio regime de pagamento, não uso de recursos ou qualidade).
1.3 — Ocupação sem 2020–2021	Nova tabela comparativa (com/sem o biênio) por categoria, com a ressalva do grupo Privado embutida. Exclusão por ano civil completo (denominador de ocupação não é decomponível por procedimento). Efeito: internação quase estável; UTI cai 1–2 p.p. na mediana e 3–6 p.p. na média.
1.4 — Escala do TMP	Gráficos em log substituídos por escala linear com teto fixo de 35 dias (não 120: nenhuma observação passa de 41 na base inteira). O achado importante virou a Pergunta 1 do memorando: o TMP é censurado em ~30,5 dias (80 hospital-ano empilhados no teto).
1.5 — Correção IPCA na camada descritiva	Os modelos já usavam faturamento real (IPCA dez/dez, base 2025); agora as tabelas descritivas ganharam a coluna real ao lado da nominal e as figuras descritivas passaram a exibir o real. Fator conferido por cálculo independente (1,6479 ✓).
1.6 — Sorocaba × Pérola Byington	"Comparativo de atendimento" definido como perfil de complexidade atendida ano a ano. Nova figura/tabela: em Sorocaba a fração de alta complexidade não cai após a conversão (sobe até 12,4%) — não há sinal de melhora por emagrecimento de case-mix; no Pérola há queda de composição concomitante (~29%→~24%) com volume ×2,5, registrada como ressalva.
1.9 — Classificação institucional	Ratificação da reunião documentada nos critérios (HU-UFSCar permanece agrupado em "Privado"); nenhuma mudança de código era necessária.
1.8 — Ocupação de UTI (decisão de trabalho)	Mistério explicado: mesmo numerador, denominadores diferentes — leitos SUS anuais (série atual) vs. fotografia Barcelona de 2026 aplicada retroativamente; as séries se cruzam em 2022. Decisão de trabalho: leitos SUS anuais como padrão, sujeita à confirmação (Pergunta 2 do memorando).

3. Achados que corrigiram premissas da própria reunião

- **Alta complexidade dos Filantrópicos (1.1): não há bug.** A mediana interna é 0,1%, mas o grupo concentra **71% da alta complexidade estadual** — os "75%" citados são participação no total, não proporção interna. Decisão: a proporção agregada vira a estatística primária nas tabelas.
- **O -6,7% de faturamento das OSS (1.7) não é um achado:** IC95% de -22,6% a +12,4%, não significativo em todas as especificações e métodos — e pode ser artefato do próprio regime de pagamento (orçamento global). Passa a circular sempre com IC e com a ressalva.
- **Mortalidade dos oncológicos:** os oncológicos **adultos** têm mortalidade mais ALTA que os pares (8,8% vs 5,4%, sustentada dentro da mesma faixa de complexidade) — a mortalidade baixa é dos **onco-pediátricos**. Isso levou à inclusão do GPACI Sorocaba (câncer infantil, mortalidade 1,1%) na lista de exclusão.
- **Exclusão pediátrica não é neutra para o desenho:** sem os hospitais da lista, a mortalidade mediana da Direta sobe de 4,75% para 5,85% (contra 4,93% da OSS) — a comparação simples **inverte de sinal**.

4. Lista de exclusão proposta (21 CNES) — pendente de ratificação

9 pediátricos/onco-pediátricos (Darcy Vargas, Menino Jesus, HMCA, Cândido Fontoura, Boldrini, GRAACC, 2 Casas da Criança, GPACI Sorocaba), **1 psiquiátrico** (Inst. de Psiquiatria HCFMUSP — escapou do filtro por especialização em branco) e **11 crônicos/reabilitação/ex-sanatórios**. Painel projetado: **314 → 293 CNES (3.223 hospital-ano)**. Nenhum é conversor nem Privado. Princípio metodológico (por que excluir esses e manter maternidades) documentado nos critérios do painel. Quatro casos seguem pendentes de leitura do Alberto: São Leopoldo Mandic, N. Sra. da Divina Providência, Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (população carcerária) e Santa Casa de S. Bernardo do Campo (perfil de retaguarda em consolidação).

5. O que depende da equipe (memorando pronto para envio)

Para quem	Decisão
Alberto	P1: confirmar se há teto de diárias por AIH (~30 dias) — define o tratamento dos ~18 hospitais de longa permanência nos modelos de TMP.
Alberto	P2: escolher o denominador oficial da ocupação de UTI (leitos SUS anuais — recomendação técnica e prática atual —, leitos totais anuais, ou fotografia Barcelona).
Priscilla	P3: ratificar em conjunto a lista de 21 exclusões e a simplificação da mortalidade para <code>mort_all</code> , sabendo que a combinação deixa o modelo de mortalidade sem ajuste de composição intra-hospitalar temporal; alternativas (controle por fração de alta complexidade; estratificação descritiva com corte de denominador) estão descritas com seus vieses.

6. Próximos passos

- Envio do memorando (após leitura final do João) e reunião de quarta/quinta.
- Com as ratificações: **Etapa 3** — reexecução única do pipeline (novo funil "ETAPA F" auditado, painel ~293 CNES, aposentadoria de `mort_sem_excl / complexidade_pond_mort`) e **Etapa 4** — reestimação completa da Fase 2, regeneração de figuras/tabelas e revisão dos textos; a seleção de entrevistas da fase qualitativa é refeita na sequência.
- Em paralelo: bateria de 8 gráficos de cruzamento (proposta de layouts aguardando aprovação).

Garantias de processo mantidas em todo o ciclo: nenhuma mudança sem justificativa nomeada e auditoria; lógica de dados somente em scripts `.py` reproduzíveis; correções uma a uma com diff e aprovação explícita; nenhum hospital excluído do painel em código até a ratificação (tudo documentado para o ciclo único da Etapa 3).

